Tema: Atendimento de vítimas de violência sexual e doméstica **Versão Nº** 02

Protocolo Nº 128 **1ª Versão:** dezembro de 2016 **Atualização:** março de 2023

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 2
OBJETIVO 3
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 3
ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 3
FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 4
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 5
CONCEITOS 5
EXAMES COMPLEMENTARES 5
DIAGNÓSTICO 5
ROTEIRO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 6
ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA 9
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUAIS TRANSMISSÍVEIS NÃO VIRAIS 10
HEPATITE B 11
PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 11
PROFILAXIA DO TÉTANO 12
ORIENTAÇÃO PARA ABORTO LEGAL (NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 2012) 12
MÉTODOS DE INTERRUPÇÃO ATÉ 12 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL 13
MÉTODOS DE INTERRUPÇÃO APÓS 12 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL 13
PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO MISOPROSTOL PARA INTERRUPÇÃO DE GESTAÇÃO 14
PARTO DE RN DE VIOLÊNCIA SEXUAL 14
CRITÉRIO DE SAÍDA DO PROTOCOLO 15
MONITORAMENTO 15
CONFLITOS DE INTERESSE 16
REFERÊNCIAS 16
SIGLAS 17
ANEXO 1: COMO UTILIZAR O KIT PADRÃO DE COLETA DE VESTÍGIOS 18
ANEXO 2 - FICHA DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 20
HISTÓRICO DAS VERSÕES 22

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

INTRODUÇÃO

Violência contra mulheres se define como "qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto privada" [1].

A luta contra a violência no Brasil teve maior representatividade após 1988[2] com a inclusão do artigo que coíbe a violência intrafamiliar na Constituição Federal. Seu principal marco é a *Lei Maria da Penha* de 2006, que aumenta o rigor das punições das agressões contra a mulher [3] e o lançamento do *Pacto Nacional para o Enfrentamento da Violência contra as Mulheres* em 2007, no qual o Ministério da Saúde se responsabilizou pela estruturação das redes de atendimento às mulheres vítimas de violência[4]. Desde março de 2008 o Governo do Estado de Minas Gerais torna obrigatória a oferta de serviço de atendimento médico específico para as vítimas de violência sexual em municípios com mais de 100.000 habitantes do Estado.

Estima-se que o Brasil gaste 2% do PIB com assistência à saúde resultante de violência, não somente contra mulheres[5]. A violência pode ser classificada em física, doméstica, moral, sexual, patrimonial, psicológica, institucional, assédio sexual e tráfico de mulheres. Ela é uma violação dos Direitos Humanos, tem caráter multidimensional e requer ações de prevenção, combate, assistência e garantia dos direitos de cidadania.

Em 2009, o conceito de estupro foi revisto a partir da Lei 12.015 que o descreve como o "ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso". Desde agosto de 2013 o Governo Federal dispôs na Lei 12.845 que os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual o atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual e o encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida.

A violência contra mulheres no âmbito doméstico e a violência sexual são fenômenos sociais e culturais ainda cercados por silêncio e dor. Estima-se que 54% dos casos são causadas pelo companheiro ou parceiro íntimo de forma crônica e ainda pouco revelada. Essas mulheres têm maior mortalidade na idade reprodutiva e todos os casos suspeitos devem ser investigados e notificados, principalmente quando essas pacientes são atendidas em pronto-atendimentos ou unidades de trauma. Os protocolos de atendimento à saúde da mulher devem obrigatoriamente incluir na anamnese questões sobre possível violência, seja ela de qualquer natureza, pois muitos dos casos começam no início da adolescência e geralmente o agressor é muito próximo da vítima[5].

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

OBJETIVO

- normatizar o acolhimento, conduta propedêutica e terapêutica para atendimento de pacientes vítimas de violência sexual ou doméstica no Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG), baseado nas melhores evidências científicas. Essa normatização favorecerá o atendimento humanizado às pacientes, ações de prevenção, combate a violência, assistência e garantia dos direitos de cidadania.

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

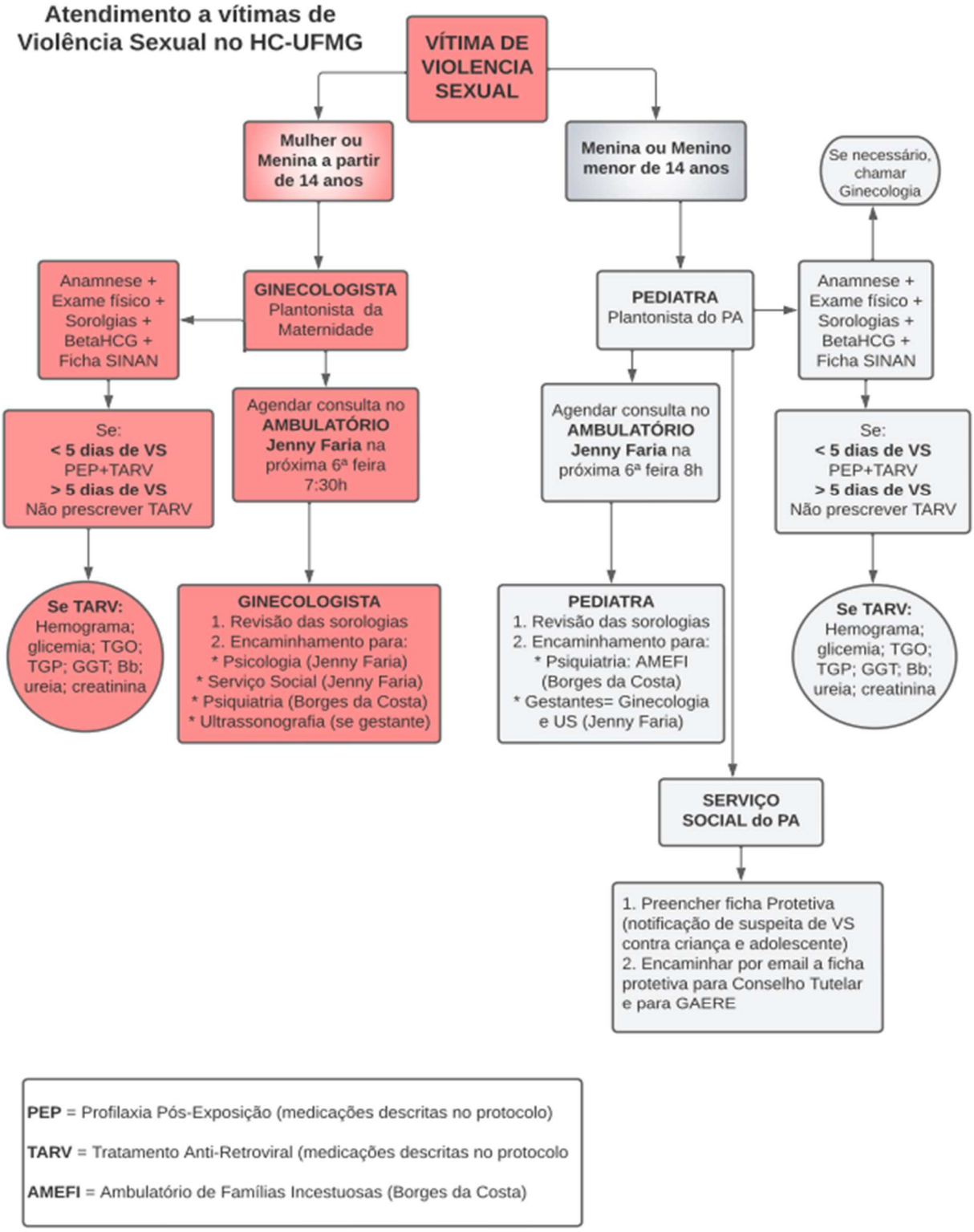
Todas as pacientes do sexo feminino e pacientes do sexo masculino até 14 anos de idade incompletos com relato de violência sexual ou doméstica.

ATRIBUIÇÕES, COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Enfermeiro	– Coordenar as ações de sua equipe durante o atendimento ambulatorial. – Participar da reunião multidisciplinar. – Registrar em prontuário as atividades realizadas.
Assistente social	– Orientar o paciente sobre as legislações que coíbem violência, redes de proteção, sobre denúncia, Delegacias de Mulheres e da Infância e Adolescência. – Acionar Conselho Tutelar em caso de vítimas menores de idade. – Encaminhar ficha de notificação ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica. – Monitorar os casos atendidos. – Participar da reunião multidisciplinar.
Psicólogo	– Atendimento psicológico dos pacientes atendidos. – Participar da reunião multidisciplinar.
Médico	– Atendimento dos pacientes. – Articulação das ações de prevenção e atenção à saúde. – Orientação dos Residentes. – Discussão dos casos e determinação de condutas. – Prescrever e orientar a administração de medicamentos. – Registrar em prontuário as atividades realizadas. – Acompanhamento ambulatorial por pelo menos 6 meses. – Participar e coordenar a reunião multidisciplinar. – Coordenar grupo multidisciplinar nas indicações de aborto legal.
Laboratório	– Coletar material para exames.
CCIH	– Acompanhar a prescrição de antibióticos e retrovirais de acordo com as normas da CCIH.
Gestores de área	– Fazer a previsão e controle de materiais de consumo médico-hospitalar e bens permanentes para abordagem da violência. – Garantir a aplicação das medidas cabíveis diante de não conformidades. – Garantir infraestrutura adequada e aquisição de suprimentos. – Garantir a provisão e gerenciamento de recursos humanos adequados.
Diretoria Geral	– Garantir infraestrutura adequada e aquisição de suprimentos. – Garantir a provisão e gerenciamento de recursos humanos adequados.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO



PEP = Profilaxia Pós-Exposição (medicações descritas no protocolo)

TARV = Tratamento Anti-Retroviral (medicações descritas no protocolo

AMEFI = Ambulatório de Famílias Incestuosas (Borges da Costa)

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A Classificação de Risco será aplicada no primeiro atendimento no Pronto Socorro. Todo atendimento em violência sexual deve ser classificado como LARANJA.

A avaliação dos riscos deverá ser feita junto com a (o) usuária (o). É preciso identificar as situações de maior vulnerabilidade a fim de elaborar estratégias preventivas de atuação

CONCEITOS

- Violência sexual: qualquer forma de atividade sexual não consentida.
- Violência doméstica ou pelo parceiro íntimo: quando a mulher sofre algum tipo de violência (sexual, física, psicológica, comportamento controlador, restrição econômica) pelo parceiro ou parceira íntima.
- Violência física: uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas evidentes.
- Agressor: aquele que ataca e agride.
- Violência contra mulheres: qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto privada.

EXAMES COMPLEMENTARES

- Hemograma, coagulograma, bioquímica renal, provas de função hepática, glicemia.
- Sorologias: VDRL, Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg, Anti-HBs.
- Beta-HCG.

DIAGNÓSTICO

- O atendimento das pacientes vítimas de violência começa pelo acolhimento a partir de um projeto de humanização do serviço baseado no respeito, ausência de julgamento moral, solidariedade e cuidado.
- As pacientes são informadas sobre o fluxo de atendimento e procedimentos. Sua autonomia é respeitada.
- O suporte emocional é oferecido no primeiro atendimento numa situação mais crítica e a cada encaminhamento ambulatorial. A história clínica é registrada em prontuário assim como todos os outros passos do atendimento.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- A paciente é submetida a exame ginecológico completo e verifica-se a presença de lesões ou secreções decorrentes do ato violento. Quando o atendimento é realizado dias ou meses após o ato de violência, o exame físico e ginecológico também é realizado.

- O registro da história da violência deve conter: local, dia e hora aproximada, tipo de violência sexual sofrido, formas de constrangimento utilizado, tipificação e número de autores da violência e órgão que realizou o encaminhamento quando for o caso.

- As providências instituídas também devem ser registradas: atendimento de emergência em outro serviço de saúde e medidas realizadas, realização do Boletim de Ocorrência Policial, comunicação ao Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e da Juventude para crianças e adolescentes, outras medidas legais cabíveis e verificar o acesso e a necessidade da mulher às diferentes possibilidades de apoio familiar e social, incluindo-se a questão de abrigos de proteção.

- Se há gravidez decorrente da violência sexual, suspeita ou confirmada, a paciente é orientada dos seus direitos de permanecer ou interromper a gravidez; e apresentar alternativas à interrupção da gravidez, assistência ao pré-natal ou entregar o recém-nascido a adoção.

- Ao se diagnosticar traumatismos físicos, genitais ou extragenitais, determinam-se as medidas clínicas e cirúrgicas.

- Desde 24/11/2003 através da Lei 10.778, é compulsória a notificação dos casos de violência contra a mulher. A notificação é realizada pelo médico ginecologista ou pediatra através da Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violências. Os dados coletados por meio desta ficha são processados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

- O sigilo no atendimento é garantido.

ROTEIRO DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

- Após o atendimento médico, todos pacientes devem ser encaminhados ao Serviço Social. As mulheres serão atendidas pela equipe Jenny Faria, de acordo com marcação após consulta ambulatorial. No caso de crianças, o atendimento deve ser realizado pela equipe do PA de 07:00 às 19:00 horas.

- Quando o atendimento for noturno, o cuidador ou tutor da criança deve ser contactado pela equipe do Serviço Social do PA no dia seguinte para dar seguimento e tomar as providências necessárias.

- É obrigatória a notificação de todos os casos suspeitos ou confirmados de violência (preenchimento da ficha do SINAN).

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Devem-se solicitar exames laboratoriais, incluindo sorologias, de todos os casos com suspeita de contato com material biológico, mesmo os casos crônicos.
- O encaminhamento para controle ambulatorial das crianças será orientado pelo Serviço Social do PA e pelo pediatra que fez o atendimento no PA.
- Orientar a paciente ou responsável da importância da coleta de material biológico para possível identificação do DNA do agressor, pois é necessário o consentimento para essa coleta.
- A vítima de violência não precisa ser encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para colher material ou exame pericial, exceto quando é preciso fazer exame de sangue para dosagem de substâncias e drogas. Nosso atendimento serve para laudo pericial indireto.
- Todos os casos de gravidez decorrente de violência sexual devem ser atendidos no PA a qualquer hora e, posteriormente, encaminhados ao ambulatório de ginecologia para atendimento e acompanhamento.
- Atendimento médico: a pediatria do PA irá atender as crianças até 14 anos, mas contará com a ginecologia para auxiliar na dúvida do exame ou para ajudar na coleta de material para o IML. A ginecologia atenderá paciente do sexo feminino maior de 14 anos
- Preencher a Ficha de Notificação/Investigação Individual (ficha do SINAN) em uma via. A secretaria da Maternidade vai tirar uma cópia para o Serviço Social. No horário noturno, quando não há Assistente Social, deixar a ficha de notificação com a secretária do pré-parto.
- Tratamento das lesões agudas existentes.
- Coleta de exames no PA: beta – HCG nos casos agudos e na suspeita de gravidez, teste rápido de HIV, sorologias de VDRL, HbsAg, Anti-HIV e Anti-HCV. Os resultados serão avaliados na consulta ambulatorial.
- Os exames de hemograma, glicemia, TGO, TGP, GGT, creatinina, fosfatase alcalina serão solicitados apenas quando forem prescritos os retrovirais e serão realizados ambulatorialmente.
- As sorologias de VDRL, HbsAg e Anti-HCV serão solicitados ambulatorialmente até completar 6 meses de acompanhamento.
- Avaliar a possibilidade de colher teste rápido de HIV no agressor.
- Agendamento da consulta ambulatorial de acompanhamento e continuação das medicações retrovirais:

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- **Mulheres e meninas a partir de 14 anos**: na próxima **sexta-feira, às 07:30h**, no ambulatório de ginecologia de Vítimas de Violência Sexual (VVS) no 4° andar do Instituto Jenny Faria. Enviar encaminhamento no receituário e ficha do atendimento no pronto socorro.
- **Meninas e meninos menores de 14 anos:** na próxima **sexta-feira, às 07:30h** no 4º andar do Instituto Jenny Faria. Enviar encaminhamento no receituário e ficha do atendimento no pronto socorro, realizado pelo Pediatra que assistiu a vítima no Pronto Atendimento do HC UFMG.

- A profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), hepatite e HIV não é indicada em casos de violência crônica e prolongada, como nos casos de crianças em que há tipos de abusos diferentes da penetração vaginal, anal e oral. Nos casos de abuso crônico com coito recente, tentar colher exame do agressor e material biológico do menor.

- Coleta do material biológico: somente se a paciente ou responsável concordar e até 10 dias após o ato, seguindo orientação recente da equipe de sexologia forense do IML.
  - A paciente deve assinar o consentimento (4ª página da ficha de atendimento).
  - Preencher a ficha de atendimento médico do IML-HC-Policia Civil.
  - Colher 2 suabes da cavidade oral e mais dois de cada local aonde houve penetração (vaginal ou anal/perineal) e colocá-los no envelope branco destinado a cada coleta, já marcado com a etiqueta do número de atendimento.
  - Colher material de outros locais possivelmente contaminados com DNA do agressor (machucados, manchas de sangue, secreção, sêmen) após umedecer os suabes com água bidestilada e colocar os suabes nos envelopes brancos destinados à coleta de “outros locais”.
  - Em caso da vítima relatar uso de bebida alcoólica, drogas ou possível intoxicação através de substância colocada na bebida (com redução da capacidade de resistência) a paciente deve ser sempre encaminhada para exame no IML de Belo Horizonte (Rua Nícias Continentino, 1291 – Nova Gameleira, telefone 31 3379-5072) ou para o serviço Médico Legal daquela jurisdição, independentemente do horário de atendimento.
  - Em caso de interrupção legal da gestação, o material coletado deve ser colocado em um frasco estéril e identificado com a etiqueta contendo o código do kit de coleta, o nome completo e registro da paciente. Este material deve ser acondicionado no refrigerador do Bloco Obstétrico imediatamente (4º andar), para posteriormente ser recolhido pela equipe do IML juntamente com os outros materiais coletados. Coletar 2 suabes da cavidade oral da

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

gestante e colocá-los no envelope branco destinado a cada coleta, já marcado com a etiqueta do número de atendimento.

- Em caso de recém-nascido (RN) de gestante vítima de violência sexual, deverá ser coletado secreção da cavidade oral da gestante e do RN. Coletar 2 suabes da cavidade oral do RN e colocá-los no envelope branco destinado a outros locais. Escrever "material da cavidade oral do RN".
- Colocar todos os envelopes brancos com suabes dentro do envelope branco com código de barra do IML, identificando-o com nome da paciente, a data e o registro do prontuário. Este envelope já estará identificado com a etiqueta contendo o mesmo número dos tubos e envelopes de suabes. Inserir dentro do envelope uma cópia da ficha de atendimento da paciente. Lacrar o envelope branco com código de barra, carimbar e assinar.
- Destacar o encaminhamento para Delegacia de Mulheres (última página da ficha de atendimento do IML-HC) e entregar à paciente devidamente preenchido.
- Entregar o envelope à secretária do pré-parto.

- Lacrar o envelope com ficha clínica e materiais colhidos, entregá-lo à secretária da Maternidade.
- Em caso de menores com material biológico disponível para ser colhido, o responsável deve autorizar a coleta do material biológico. Se há forte suspeita que o agressor seja o responsável do menor e este não autorizou a coleta e o ou outro responsável também não autorizou, telefonar para a equipe de Sexologia Forense do IML (31 3379-5042) para avaliar a vinda da Polícia Civil ou da Promotoria. Este telefone se encontra disponível 24h por dia, 7 dias da semana.
- O Manual de Operação Padrão da Polícia civil e IML está na pasta para consulta.
- O kit de coleta de material biológico é enviado periodicamente pelo IML e possui: envelope branco com: estojo com 2 lâminas (G e P), dez suabes individuais, cinco porta-suabes (envelopes), formulário do SINAN, ficha complementar, rol de etiquetas (kit adicional), protocolo de consentimento.

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA

- Indicação: todas mulheres expostas a gravidez por contato certo ou duvidoso com sêmen.
- Período: até 5 dias após o crime sexual.
- Esquemas (via oral ou vaginal):
  - Levonorgestrel 0,75 mg 02 cp VO em dose única ou 01 cp VO de 12/12 h.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Anticoncepcional oral combinado: 04 cp VO em dose única ou 02 cp VO de 12/12h. Contraindicado quando for usado o retroviral nelfinavir ou ritonavir e nos casos de acidente vascular cerebral e tromboembolismo prévios, por causa do estrogênio.

PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUAIS TRANSMISSÍVEIS NÃO VIRAIS

- Período: até 5 dias após o crime sexual.
- Esquema para mulheres adultas e adolescentes acima de 45 Kg:
  - Penicilina benzatina 2.4 milhões de UI, intramuscular (IM), dose única (1.2 milhões de UI em cada nádega). Opção: eritromicina 500 mg, via oral (VO), 06/06 h por 15 dias.
  - Ceftriaxona 500 mg IM, dose única para pacientes até 150 Kg. Opção do ofloxacino 400 mg VO, dose única ou Ciprofloxacino 500 mg em dose única VO. Para pacientes acima de 150 Kg de peso corporal, fazer uso de ceftriaxona 1 g IM dose única
  - Azitromicina 1 g VO dose única. Opção: amoxicilina 500 mg VO 08/08 h por 7 dias.
  - Metronidazol 2 g (08 comprimidos de 250 mg) VO dose única.

- Esquema para crianças e adolescentes abaixo de 45 Kg
  - Penicilina benzatina 50 mil UI/Kg, IM, dose única. Opção de eritromicina 50 mg/Kg/dia 06/06 horas, VO, por 15 dias.
  - Ceftriaxona 250 mg IM dose única.
  - Azitromicina 20 mg/Kg, VO, dose única.
  - Metronidazol 15 mg/Kg/dia, VO, 08/08 horas por 07 dias.

- Esquema para gestantes
  - Penicilina benzatina 2.4 milhões de UI, IM, dose única (1.2 milhões de UI em cada nádega). Opção de eritromicina 500 mg VO 06/06 h por 15 dias.
  - Ceftriaxona 500 mg IM dose única.
  - Azitromicina 1 g VO dose única. Opção de eritromicina 500 mg VO 06/06 h por 07 dias.
  - Metronidazol 2 g (08 comprimidos de 250 mg) VO dose única.
- Obs.: pode ser postergada a critério do médico (individualizar no caso de crianças)

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

HEPATITE B

- Indicação: casos de violência com exposição ao sêmen, sangue ou outros fluidos corporais do agressor.
- Período: até 14 dias após o crime sexual.
- Contraindicada em mulheres e crianças imunizadas (anti-HBs positivo) corretamente.
- Esquema em mulheres, gestantes e crianças não imunizadas ou que desconhecem o status vacinal:
  - Prescrever a 1ª dose da vacina, IM, no deltoide, ou completar a dose que falta.
  - Ao receitar a 1ª dose, orientar receber a 2ª dose com 1 mês e a 3ª dose após 6 meses.
  - Dose única da Imunoglobulina humana anti-hepatite B, IM, 0,06ml/kg.

  Prescrição em receituário e preencher a Ficha para Registro no Centro de Referência de Imunobiológicos especiais (CRIE) conforme modelo que está na pasta. A paciente não precisa aguardar no HC a chegada da imunoglobulina. Com a prescrição no receituário e a ficha de registro ela é orientada a procurar o CRIE logo depois o atendimento médico em horário comercial.

  CRIE: Rua Domingos Vieira, 488, 2º andar - Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte / tel.: (31) 3277-7726 | 3277 -5301.

PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV

RECOMENDADA	Violência sexual com penetração vaginal ou anal desprotegida com ejaculação sofrida há menos de 72 horas
INDIVIDUALIZAR DECISÃO	Penetração oral com ejaculação
NÃO RECOMENDADA	Penetração oral sem ejaculação Agressor sabidamente HIV negativo Violência sofrida há mais de 72 horas Abuso crônico pelo mesmo agressor

- Indicação: casos de penetração anal ou vaginal com ou sem coito oral.
- Período: até 72 horas após o crime sexual.
- Esquema para mulheres adultas, adolescentes > 45 kg e gestantes com mais de 12 semanas:
  - Tenofovir (TDF) de 300mg associado a Lamivudina (3TC) de 300mg, 1 comprimido ao dia.
  - Dolutegravir (DTG) de 50mg, 1 comprimido ao dia.
  - Posologia: TDF/3TC (1comprimido ao dia) + DTG (1comprimido ao dia)

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

OBS: gestantes ≤ 12semanas ou suspeita de gestação: tenofovir de 300 mg associado a lamivudina de 300 mg, 1 comprimido ao dia + Atazanavir (ATZ) 300 mg, 1 comprimido ao dia + Ritonavir (RTV) 100 mg, 1 comprimido ao dia.

  - Posologia: TDF/3TC (1comprimido ao dia) + ATV (1comprimido ao dia) + RTV (1comprimido ao dia)

- Duração do tratamento: 28 dias
- Lembrar de interações medicamentosas com tuberculostáticos, hipnóticos, antidepressivos e anticonvulsivantes.

PROFILAXIA DO TÉTANO

- Indicação: casos de lesões perfurocortantes
- Período: até 72 h após a lesão. Geralmente é realizada no Posto de Saúde com prescrição realizada no atendimento médico. Encaminhar ao CRIE.

HISTÓRIA DE VACINAÇÃO CONTRA TÉTANO	FERIMENTO LIMPO OU SUPERFICIAL		OUTROS TIPOS DE FERIMENTO	
	VACINA	SAT ou IGHAT*	VACINA	SAT ou IGHAT*
Incerta ou menos de 3 doses	sim	não	sim	sim
3 doses ou mais; última dose há menos de 5 anos.	não	não	não	não
3 doses ou mais; última dose entre 5 a 10 anos.	não	não	sim	não
3 doses ou mais; última dose há mais de 10 anos.	sim	não	sim	não

(*) 5.000 unidades de SAT (soro antitetânico) via I.M. após realização do teste de sensibilidade, aos alérgicos ao SAT indicar imunoglobulina humana dose única de 250 unidades.

ORIENTAÇÃO PARA ABORTO LEGAL (NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 2012)

- O Código Penal não exige qualquer documento para a prática do abortamento.
- Exames do tipo sanguíneo, fator Rh e hemograma devem ser procedimentos de rotina.
- O HC-UFMG NÃO realiza interrupção da gravidez após 20 semanas de idade gestacional.
- Recomenda-se que amostras do material embrionário do abortamento induzido sejam guardadas para eventual investigação de DNA e encaminhadas ao IML. Coletar também suabe oral da paciente, para avaliação de DNA. Deixar os dois materiais juntos (colocar o frasco com material embrionário

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

em saco plástico para não vazar) dentro do envelope de coleta de vestígio do IML, acondicionando na geladeira do bloco obstétrico, com a cópia da notificação e autorização de coleta de material biológico assinado pela paciente. Esse material deve ficar sob custódia da chefia de Enfermagem do plantão.

- É fundamental que a equipe de saúde garanta alívio apropriado para a dor em cada tipo de procedimento de interrupção de gravidez.

MÉTODOS DE INTERRUPÇÃO ATÉ 12 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL

- Para a interrupção da gravidez de até 12 semanas de idade gestacional o método de escolha é a aspiração a vácuo intrauterina. Em gestações de primeiro trimestre, principalmente entre nove e doze semanas, a preparação ou maturação do colo de útero com misoprostol torna o procedimento de esvaziamento uterino (aspiração a vácuo ou curetagem) mais rápido e com menor risco de complicações imediatas. O método é particularmente indicado para nulíparas e adolescentes, ou para aquelas que apresentam anomalia ou cirurgia cervical prévia. Recomenda-se utilizar dose única de 400 microgramas de misoprostol, via vaginal, de três a quatro horas antes do procedimento.

- A segunda opção é o uso de misoprostol. As evidências mais recentes permitem recomendar a dose de 800 microgramas, aplicada nos fundos de saco laterais da vagina, a cada 3 - 12 horas, até completar três doses. A maioria dos abortamentos ocorre nas primeiras 24 horas e, em alguns casos, pode ser necessário aguardar até 72 horas pela expulsão fetal. Após esse prazo, não ocorrendo o abortamento, o misoprostol pode ser repetido, nas mesmas doses, por até uma semana do início do tratamento. Pode-se, também, optar pela aspiração a vácuo ou pela curetagem uterina, considerando-se o desejo da mulher.

- O misoprostol é contraindicado em mulheres ou adolescentes com disfunção hepática grave, com coagulopatias ou em uso de anticoagulante, e com antecedente de alergia às prostaglandinas. Em portadoras de doenças cerebrovasculares, cardíacas ou vasculares; neuropatias, diabetes mellitus ou hipertensão arterial descompensada, o misoprostol deve ser acompanhado de rigorosa vigilância.

MÉTODOS DE INTERRUPÇÃO APÓS 12 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL

- No segundo trimestre, o abortamento medicamentoso constitui método de eleição.
- Para as gestações com mais de 12 e menos de 22 semanas de idade gestacional recomenda-se a utilização do misoprostol para a dilatação cervical e expulsão do concepto.
- Entre os esquemas disponíveis, recomenda-se utilizar 400 mcg de misoprostol, via vaginal, via oral ou via sublingual a cada 3 horas.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Em casos de hemorragia ou sinais de infecção, evitar a via vaginal (vide tabela abaixo com os regimes recomendados pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia - FIGO).
- A aspiração intrauterina ou a curetagem devem ser realizadas apenas após expulsão do concepto.

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO MISOPROSTOL PARA INTERRUPÇÃO DE GESTAÇÃO



MISOPROSTOL SOZINHO
REGIMES RECOMENDADOS 2017

FIGO
www.figo.org

< 13 semanas de gestação	13–26 semanas de gestação	> 26 semanas de gestação[8]	Uso pós-parto
Interrupção da gravidez[a,b,1] 800 µg VSI a cada 3 horas *ou* VV*/VB a cada 3–12 horas (2–3 doses)	**Interrupção da gravidez**[1,5,6] 13–24 semanas: 400 µg VV*/VSI/VB a cada 3 horas[4,c] 25–26 semanas: 200 µg VV*/VSI/VB a cada 4 horas[1]	**Interrupção da gravidez**[1,5,9] 27–28 semanas: 200 µg VV*/VSI/VB a cada 4 horas[10] > 28 semanas: 100 µg VV*/VSI/VB a cada 6 horas	**Profilaxia da hemorragia pós-parto (HPP)**[i,2,10] 600 µg VO (x1) *ou* **prevenção secundária da HPP**[j,11] (perda de sangue aprox. ≥ 350 ml) 800µg VSI (x1)
Aborto retido[c,2] 800 µg VV* a cada 3 horas (x2) *ou* 600 µg VSI a cada 3 horas (x2)	**Morte fetal**[f,g,1,5,6] 200 µg VV*/VSI/VB a cada 4–6 horas	**Morte fetal**[2,9] 27–28 semanas: 100 µg VV*/VSI/VB a cada 4 horas[7] > 28 semanas: 25 µg VV* a cada 6 horas *ou* 25 µg VO a cada 2 horas[5]	**Tratamento da HPP**[k,2,10] 800 µg VSI (x1)
Aborto incompleto[a,2,3,4] 600 µg VO (x1) *ou* 400 µg VSI (x1) *ou* 400–800 µg VV* (x1)	**Aborto inevitavel**[a,2,3,5,6,7] 200 µg VV*/VSI/VB a cada 6 horas	**Indução do parto**[h,2,9] 25 µg VV* a cada 6 horas *ou* 25 µg VO a cada 2 horas	
Preparação cervical para aborto cirúrgico[d] 400 µg VSI 1 hora antes do procedimento *ou* VV* 3 horas antes do procedimento	**Preparação cervical para aborto cirúrgico**[d] 13-19 semanas: 400 µg VV 3–4 horas antes do procedimento > 19 semanas: tem que ser combinado com outras modalidades		

References
a WHO Clinical practice handbook for safe abortion, 2014
b von Hertzen et al. Lancet, 2007; Sheldon et al. 2016 FIAPAC abstract
c Gemzell-Danielsson et al. IJOG, 2007
d Sääv et al. Human Reproduction, 2015; Kapp et al. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010
e Dabash et al. IJOG, 2015
f Perritt et al. Contraception, 2013
g Mark et al. IJOG, 2015
h WHO recommendations for induction of labour, 2011
i FIGO Guidelines: Prevention of PPH with misoprostol, 2012
j Raghavan et al. BJOG, 2015
k FIGO Guidelines: Treatment of PPH with misoprostol, 2012

Notas
1 Se a mifepristona estiver disponível (preferencial), siga o regime posológico prescrito para mifepristona + misoprostol
2 Incluído na Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da OMS
3 No caso de aborto incompleto/ inevitavel, a mulher deve receber um tratamento baseado em seu tamanho uterino e não na idade gestacional determinada por data da última menstruação (DUM)
4 Deixar surtir efeito durante 1 ou 2 semanas exceto no caso de hemorragia excessiva ou infecção
5 Pode ser administrada uma dose adicional caso a placenta não tenha sido expelida 30 minutos após a expulsão fetal
6 Vários estudos limitaram a dosagem a 5 doses; a maioria das mulheres apresentaram expulsão total antes da utilização das 5 doses, mas outros estudos continuaram para além das 5 doses e obtiveram uma taxa de sucesso total superior sem problemas de segurança
7 Incluindo rotura das membranas quando parto for indicado
8 Seguir o protocolo local no caso de cesárea prévia ou cicatriz uterina transmural
9 Se apenas estiverem disponíveis comprimidos de 200 µg, podem ser preparadas doses inferiores dissolvendo-os em água (ver www.misoprostol.org)
10 Se não estiver disponível oxitocina ou se as condições de conservação forem inadequadas
11 Opção para programas comunitários

Via de administração
VV: via vaginal
VSI: sublingual (por baixo da língua)
VO: oral
VB: bucal (entre a bochecha)
* Evitar VV (via vaginal) no caso de hemorragia e/ou sinais de infeção
A via retal não está incluída como via recomendada devido ao perfil farmacocinético não estar associado à melhor eficácia por esta via

PARTO DE RN DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Em RN a tempo ou prematuro, o material coletado deverá ser acondicionado como descrito a seguir.

– Retirar 4 suabes do KIT ROTINA, para colher material da cavidade oral (para avaliação do DNA da paciente e do RN).

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Cavidade oral da gestante: introduzir dois suabes simultaneamente na cavidade oral, com movimentos giratórios junto à mucosa interna, lateralmente. Colocar os dois suabes no envelope escrito “oral”.
- Cavidade oral do recém-nascido: introduzir dois suabes simultaneamente na cavidade oral, com movimentos giratórios junto à mucosa interna, lateralmente. Colocar os dois suabes no envelope escrito “OUTROS LOCAIS” e escrever “cavidade oral do RN”.
- Colocar os envelopes dos suabes dentro do envelope pardo, identificando-o com nome da paciente, a data e o registro do prontuário. Este envelope já estará identificado com a etiqueta contendo o mesmo número dos tubos e envelopes de suabes. Lacrar o envelope parto, carimbar e assinar. O envelope pardo deve ser colocado dentro do envelope de plástico, também identificado com etiqueta contendo mesmo número de identificação.
- Destacar o encaminhamento para Delegacia de Mulheres (última página da ficha de atendimento do IML-HC) e entregar à paciente devidamente preenchido
- Grampear o envelope de plástico contendo o envelope pardo e todos os materiais coletados na ficha de atendimento e entregar à secretária do pré-parto.
- Em caso de menores com material biológico disponível para ser colhido, o responsável deve autorizar a coleta do material biológico.

CRITÉRIO DE SAÍDA DO PROTOCOLO

O critério de saída do protocolo é individualizado. Geralmente, após o primeiro atendimento a paciente fica em acompanhamento ambulatorial por 6 meses, para avaliação sorológica e acompanhamento emocional.

MONITORAMENTO

O monitoramento do protocolo é realizado através dos seguintes indicadores:

- Número de atendimentos;
- Tempo de acompanhamento ambulatorial;
- Intercorrências clínicas;
- Conversão sorológica no acompanhamento ambulatorial;
- Número de abortos legais e correlação com a contracepção de emergência;
- Necessidade de busca ativa das pacientes atendidas.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

CONFLITOS DE INTERESSE

Os participantes declaram não haver conflito de interesse.

REFERÊNCIAS

1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, "Convenção de Belém do Pará" (Adotada em Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 1994, no Vigésimo Quarto Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral) ww.cidh.org/basicos/portugues/n.belem.do.para.ratif..htm

2. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm. Constituição Federal do Brasil, em seu parágrafo 8º, art. 226.

3. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004.../lei/l11340.htm. *Lei Maria da Penha*

4. *Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres.* http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/pacto/texto-pacto-enfrentamento-violencia-contra-mulheres.

5. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Ministério da Saúde. 2012

6. Protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual: orientações médico-legais para abordagem nos hospitais referenciados. Programa de Humanização do atendimento à vítima de violência sexual. Superintendência de Polícia Técnico-Científica – SPTC. Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte - MG. 2018

7. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Ministério da Saúde, 2012.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

SIGLAS

AMEFI	Ambulatório de Famílias Incestuosas
ATZ	Atazanavir
CCIH	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)
CRIE	Centro de Referência de Imunobiológicos especiais
DST's	Doenças Sexualmente Transmissíveis
DTG	Dolutegravir
FIGO	Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia
IM	Intramuscular
IML	Instituto Médico-Legal
PA	Pronto-Atendimento
PCH	Produtos de Concepção Humana
PEP	Profilaxia pós-exposição
RN	Recém-nascido
RTV	Ritonavir
TARV	Tratamento anti-retroviral
TDF	Tenofovir
VO	Via oral
VVS	Vítimas de Violência Sexual
3TC	Lamivudina

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

ANEXO 1: COMO UTILIZAR O KIT PADRÃO DE COLETA DE VESTÍGIOS

O Kit Padrão compõe-se de um envelope branco, com adesivo prateado escrito POLÍCIA CIVIL na aba para lacrar o mesmo que, após retirado o lacre e fechado, só poderá ser aberto pela equipe da Polícia Civil. Este envelope deve ser preenchido com o nome completo e data de nascimento da paciente, assim como a data e local da coleta dos vestígios (HC-UFMG), nome e assinatura do médico responsável pela coleta.

O Kit completo deve conter:

- Um envelope branco com código de barra com orientações quanto ao seu manuseio, onde deverão ser inseridos os porta-suabes (envelopinhos) contendo os suabes impregnados por material biológico e externamente anexadas as lâminas e a autorização de coleta.
- Um estojo aderido ao envelope pardo no qual há duas lâminas (com identificação G e P – que em breve terão numeração correspondente ao kit).
- Dez suabes em embalagens próprias seladas.
- Quatro porta-suabes (envelopinhos) com aba adesiva descriminando o tipo de coleta (oral, vaginal, perineal, outros locais).
- Um formulário do SINAN (frente e verso).
- Um formulário da Ficha complementar (frente e verso).
- Protocolo de consentimento que deve ser preenchido e assinado pelo médico que fará a coleta. Este protocolo deve ser entregue à paciente com a orientação de que ela deve fazer a Representação na Polícia Civil e entregar este documento na Delegacia de Mulheres – Av. Barbacena, 288 Barro Preto – BH, MG.

KIT ROTINA:

- Calçar luvas estéreis e mantê-las durante todo o procedimento de coleta de vestígios.
- Abrir os invólucros contendo os suabes e fazer a coleta do material como descrito a seguir:
  - Cavidade oral: introduzir dois suabes simultaneamente na cavidade oral, com movimentos giratórios junto à mucosa interna, lateralmente. Colocar os dois suabes no envelope escrito “oral”.
  - Outro local: para coleta de material em outro local, umedecer dois suabes com água estéril e deslizar sobre a área corpórea alvo. Após fazer a coleta, colocar os suabes no envelope assinalado como “outro local”, indicando o local de coleta (ex: mamas, braços, joelhos, costas, etc).

- Inspecionar a região perineal, incluindo vulva e região perianal. Tracionar os grandes lábios, para visualizar adequadamente o introito vaginal e introduzir o espéculo (nos casos indicados – penetração vaginal).
  - Esfregaço Genital: introduzir o espéculo vaginal para avaliar parede vaginal, colo uterino e fundo de saco. Colher a secreção no fundo de saco e fazer o esfregaço genital na lâmina com a inicial “G” (genital). Após fazer a coleta, colocar os suabes no envelope assinalado “G”.
  - Esfregaço Perianal: o procedimento de coleta é semelhante ao esfregaço genital, contudo os suabes devem ser umedecidos previamente com a água estéril. Colher o material esfregando levemente de forma giratória

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

os suabes umedecidos na região perianal (não há necessidade de introduzir na região anal) e fazer o esfregaço na lâmina com a inicial “P” (perianal). Após fazer a coleta, colocar os suabes no envelope assinalado “P”.

PRODUTO DE CONCEPÇÃO HUMANA (PCH):

Em caso de interrupção legal da gestação, o material coletado deverá ser acondicionado como descrito a seguir.

- Produto de concepção humana: colocar os restos ovulares, embrionários ou placentários em um frasco estéril (frasco estéril de coletar urina – sem conservante ou formol).
- Identificar o frasco com a etiqueta com código de barra e outra etiqueta com nome completo, data de nascimento e prontuário da paciente.
- Inserir o frasco com material colhido dentro do saco plástico do KIT ADICIONAL.
- Retirar 2 suabes do KIT ROTINA, para colher material da cavidade oral (para avaliação do DNA da paciente). Depois de colher a saliva da paciente, inserir os dois suabes dentro do envelope branco designado para cavidade oral, grampear e colocar dentro do envelope BRANCO com código de barras. Inserir uma cópia do atendimento da paciente dentro do envelope antes do mesmo ser lacrado.
- Destacar o encaminhamento para Delegacia de Mulheres (última página da ficha de atendimento do IML-HC) e entregar à paciente devidamente preenchido.
- Entregar o envelope BRANCO com código de barra lacrado à enfermeira supervisora da unidade para acondicionamento sob dentro do refrigerador no Bloco Obstétrico (4º andar) até o recolhimento pela Delegacia.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

ANEXO 2 - FICHA DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Hospital das Clínicas da UFMG Ambulatório de Violência Sexual

>> Registro Clínico

FICHA DE ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL – 1ª CONSULTA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Data do Atendimento: Hora do Atendimento:

Nome completo: **PRONTUÁRIO:**

- Data de Nascimento: Idade: Documento de Identificação:
- Cartão Nacional da Saúde (CNS):
- Nome da mãe: Tamara Cristina de Jesus
- Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino
- Gestante: ( ) Sim ( )Não ( )Não se aplica
- Pessoa com deficiência ou transtorno psiquiátrico? ( ) Não ( )Sim, especificar:
- Endereço Completo: CEP:
- Telefone:
- Representante Legal (apenas para crianças, adolescentes ou incapazes):
  - Nome:
  - Parentesco:
  - Telefone:

COMO A PACIENTE DESCOBRIU/FOI ENCAMINHADA AO SERVIÇO DO HC?

DADOS SOBRE A OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL

- Data da Ocorrência: Hora da Ocorrência:
- Local da Ocorrência (residência, bar, estabelecimento público, escola etc.):
- Endereço da ocorrência: Bairro: Município: UF:
- Violência de Repetição? ( ) Não ( ) Sim, início há:
- Houve ameaças? ( ) Não ( )Sim, especificar:
- Houve violência física? ( ) Não ( )Sim, qual o tipo de agressão?
- Relata espontaneamente ter sofrido violência sexual? ( ) Não ( )Sim
- Se houve penetração, qual tipo? ( ) Vaginal ( )Anal ( )Oral
- Houve ejaculação? ( ) Não sabe ( )Não ( )Sim, local do corpo:
- O agressor usou preservativo? ( ) Não ( )Sim ( )Não sabe
- Durante a violência sexual estava: ( ) Consciente ( )Inconsciente ( )Sonolenta

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Utilizou ou foi forçada(o) a utilizar, nas últimas 24 horas, algum tipo de:

Relação com a pessoa que cometeu a violência sexual:

- Nº de envolvidos:
- Conhecido? ( ) Não ( )Sim, especificar:
- Idade:
- Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino
- Raça/Cor do agressor: ( ) Branca ( )Preta ( )Amarela ( )Parda ( )Indígena ( )Ignorado
- Orientação sexual: ( ) Heterossexual ( )Homossexual ( )Bissexual ( )Desconhece
- Pessoa com deficiência ou transtorno psiquiátrico? ( ) Desconhece ( )Não ( )Sim, especificar:

HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA

- Possui comorbidades? ( ) Não ( )Sim, especificar:
- Uso contínuo de medicações? ( ) Não ( )Sim, especificar:
- Situação Vacinal:
  - Tétano ( ) Não ( )Sim
  - Hepatite B ( ) Não ( )Sim
- Passado de violência física ou psicológica? ( ) Não ( )Sim, especificar:

HISTÓRIA GINECOLÓGICA PREGRESSA

- Menarca: DUM:
- Era virgem antes da agressão: ( ) Não ( )Sim
- Gestante: ( ) Não ( ) Sim, IG:
- Usava algum método Contraceptivo? ( )Não ( ) Sim, especificar:
- Última relação sexual consentida:

EXAME FÍSICO*: descrição detalhada do exame físico geral e ginecológico*

EXAMES SOLICITADOS:

Registrou Boletim de Ocorrência? ( ) Não ( )Sim - Data: Hora:

CONDUTAS E ENCAMINHAMENTOS

1. Orientar a paciente quanto ao seguimento ambulatorial por 6 meses para avaliação sorológica e emocional.
2. Solicitar sorologias: VDRL, Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg (resultados serão avaliados no ambulatório)
3. Solicitar dosagem de beta-HCG

Encaminhar para Ambulatório de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, próxima sexta-feira às 7:00h no 4º andar do Ambulatório Jenny Faria.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

HISTÓRICO DAS VERSÕES

1ª versão

- Elaborada em outubro de 2015 por Marilene Vale de Castro Monteiro e Sara de Pinho Cunha Paiva.
- Aprovada em dezembro de 2016 por Andrea Maria Silveira, gerente de Atenção à Saúde e diretora técnica.

2ª versão

- Elaborada em 2021 por Sara de Pinho Cunha Paiva.
- Aprovada em março de 2023 por Luciana Cristina dos Santos Silva, gerente de Atenção à Saúde e diretora técnica.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).